

РЕАБИЛИТАЦИЯ И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ БОЛЬНЫХ МЕЛАНОМОЙ

Аладов В.Н.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

В Павлодарском онкологическом диспансере состоит на учете 179 человек с меланомой кож, из них более 5 лет – 115. Показатель 5-летней выживаемости 64,9%.

Меланома кожи — чрезвычайно злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов (пигментных клеток, продуцирующих специфический белок — меланин). Удельный вес в общей структуре заболеваемости раковыми заболеваниями в Павлодарской области составляет от 0,5% до 1 %. Заболеваемость меланомой кожи в РК за последнее десятилетие имеет тенденцию к росту: прирост показателя составил 54,6 %. В различных регионах мира ежегодный показатель заболеваемости колеблется от 5 до 30 на 100000 населения. Заболевают меланомой кожи, в основном, лица после 30 лет.

Реабилитация онкологических больных — последовательный процесс, где на каждом этапе лечения, дальнейшего наблюдения и жизни больного применяют определенные воздействия. Основными принципами восстановительного лечения онкологических больных являются: раннее начало лечения, непрерывность, преемственность, комплексный характер, этапность медицинских мероприятий, индивидуальный подход к больному. Реабилитация при меланоме должна основываться на обязательном соблюдении следующих основных положений и требований:

1. Первичная профилактика меланомы — радикальное удаление невусов, подвергающихся травматизации, особенно меланомоопасной группы.

2. Раннее выявление и адекватное хирургическое лечение меланомы.

3. Выбор рациональных методов лечения в соответствии со стадией опухолевого процесса и особенностями его течения в каждом конкретном случае.

4. Тщательное установление показаний к комбинированным

и комплексным методам лечения, адъювантным и неоадъювантным способам терапии.

5. Выбор оптимального объема хирургического вмешательства на первичном очаге и адекватного метода пластического закрытия раневого дефекта.

6. Строгое установление показаний к простой и расширенной регионарной лимфаденэктомии.

7. Профилактика и рано начатое лечение возможного лимфостаза конечностей после регионарной лимфаденэктомии.

8. Тщательная диспансеризация больных после радикального лечения с целью раннего выявления и своевременного специального лечения возможных рецидивов и метастазов меланомы.

9. Диспансерное наблюдение за больными, леченными по поводу первичных поздних форм меланомы, рецидивов и метастазов после проведенного ранее радикального лечения, с целью проведения и коррекции специальных методов поддерживающей терапии.

Проведение комплекса реабилитационных мероприятий повышает эффективность лечения больных меланомой кожи. За больными меланомой после радикального лечения устанавливают тщательное диспансерное наблюдение с целью своевременного выявления возможных рецидивов и метастазов. Контрольные обследования проводят каждые три месяца в течение первого года и каждые шесть месяцев на протяжении второго года, затем — ежегодно. При возникновении рецидивов и метастазов больные подлежат специальному лечению в условиях соответствующего онкологического учреждения. За больными, лечение которых было нерадикальным, также устанавливают диспансерное наблюдение для контроля течения процесса и соответствующей коррекции поддерживающего специального лечения.

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ

Олжатаева Г. О.

КГКП «Областной онкологический диспансер», Караганда, Казахстан

Задачи исследования: исследовать результаты медицинской реабилитации больных раком шейки матки (РШМ).

Материалы и методы исследования. Проведен анализ медицинских дел освидетельствования 626 больных РШМ, пролеченных в КГКП «Карагандинский областной онкологический центр» за пять лет (2001-2005 гг.), 1260 историй болезней данных пациенток и 626 медицинских карточек. Все больные прошли полное клинико-лабораторное обследование. Диагноз верифицирован цитологически в (98,4±0,5)% случаев: плоскоклеточный рак — (73,2±1,6)%, железистый — (12,8±1,3)%, низкодифференцированный рак — (9,1±1,1)%, мукоэпидермоидный рак — (2,2±0,5)%, другие — (1,1±0,4)%.

У 63,6% пациенток проведено кольпоскопическое исследование: неизмененная слизистая оболочка влагалищной части шейки матки выявлена у (0,16±0,2)%, доброкачественные изменения слизистой оболочки — у (1,44±0,5)% и атипичный эпителий — у (62,0±1,9)%.

Подавляющее большинство больных (76,1%) имели II и III стадии злокачественного процесса. Запущенный процесс наблюдали в 50,8% случаев (318 пациенток) — это больные с III и IV стадиями рака. Это очень высокий показатель запущенности опухолевого процесса, учитывая визуальную локализацию рака. Остальные 49,2% приходятся на I и II стадии опухолевого процесса. В 98,4% случаев диагноз верифицирован цитоло-

гически при первичном обращении больных в поликлинику онкологического диспансера.

При анализе полученных клинических данных оценивалась безрецидивная и общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных (по Kaplan-Meier). Полученные результаты обработаны на персональном компьютере «Pentium - 4» с привлечением программы «Statistica».

Результаты. Одна треть больных РШМ (30,7±1,8%) получили комбинированное лечение: хирургическое + лучевое. При I стадии РШМ у молодых (до 50 лет) женщин было проведено хирургическое лечение в объеме расширенной экстирпации матки — операция Вертейма. У остальных больных с I стадией, а также при II и III стадиях проводилась только сочетанная лучевая терапия — ведущий метод лечения РШМ, поэтому 50,5% пациенток лучевую терапию.

Средняя суммарная очаговая доза на точку «А» составила 77,13±0,95 Грей с минимумом в 59 и максимумом в 100 Грей. Большая часть пациентов получила суммарную очаговую дозу на точку «А» от 71 до 90 Грей. Средняя суммарная очаговая доза на точку «Б» составила 58,16±0,79 Грей и варьировала от 43 до 74 Грей. Подавляющее большинство больных — 62,5% получили на точку «Б» от 55 до 64 Грей, более 65 Грей подведено у 19,6% больных. В 17,9% случаев суммарная очаговая доза на точку «Б» составила меньше 54 Грей.

Отдаленные результаты лучевой терапии прослежены у 158 больных РШМ со II и III стадиями. Кумулятивная выживаемость на первом году составила $(76,0 \pm 6,0)\%$, показатель 3-летней общей выживаемости был равен $(63,0 \pm 2,4)\%$. Показатель 5-летней выживаемости практически не меняется и составляет $(62,5 \pm 1,4)\%$.

Безрецидивная выживаемость больных РШМ после

сочетанной лучевой терапии составила на первом году – $(65,0 \pm 2,7)\%$, трехлетняя безрецидивная выживаемость – $(52,0 \pm 3,4)\%$, четырех и пятилетняя безрецидивная выживаемость составила $(41,0 \pm 3,7)\%$.

Выводы: Общая кумулятивная 5-летняя выживаемость больных РШМ составляет $62,5 \pm 1,4\%$, безрецидивная – $41,0 \pm 3,7\%$.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИОТЕРАПИИ ФТОРПИРИМИДИНАМИ В КОМБИНАЦИИ С ЦИСПЛАТИНОМ РАСПРОСТРАНЕННОГО ПЕРВИЧНОГО РАКА ПЕЧЕНИ

Омарова И.М., Кожамбердин К.Е.

Карагандинский областной онкологический диспансер

Первичный рак печени представляет серьезную проблему для здравоохранения. По данным международного агентства по изучению рака в мире ежегодно погибает более полумиллиона человек.

Интерес к проблеме лечения первичного рака печени обусловлен всё ещё неудовлетворительными результатами лечения пациентов. Общий прогноз при первичном раке печени неблагоприятный, даже при использовании современных методов лечения

Цель исследования – изучение сравнительной эффективности цисплатина в комбинации с 5-фторурацилом или капецитабином в первой линии химиотерапии первичного рака печени

Материал и методы исследования: в данное нерандомизированное исследование включено 44 пациента (32 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 34 до 76 лет с морфологически подтвержденным диагнозом распространенного первичного рака печени III – IV стадии (таблица 1).

В подгруппе А полихимиотерапия проведена по схеме: 5-ФУ 500 мг/м^2 внутривенно в 1, 3, 5, 8 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

В подгруппе В полихимиотерапия проведена по схеме: капецитабин 1000 мг/м^2 2 раза в день внутрь с 1 по 14 дни и цисплатин 100 мг/м^2 внутривенно капельно в 1 день каждого 28 дневного цикла.

Результаты и обсуждение: в подгруппе из 28 пациентов А частичный регресс отмечался у 14,3%, стабилизация заболевания – у 32,1%, прогрессирование заболевания – у 53,6% пациентов. В подгруппе В из 16 пациентов частичный регресс отмечен у 18,7%, стабилизация заболевания – у 37,5%, прогрессирование заболевания – у 43,8% пациентов (

Сравнение результатов непосредственной эффективности

химиотерапии между подгруппами не выявило достоверных различий.

Токсический профиль в обеих подгруппах был практически одинаковым, однако следует отметить, что у 37,5% больных подгруппы В отмечался ладонно-подошвенный синдром.

Пригодными для оценки выживаемости в подгруппе А явились все 28 пациентов, которым проведено 86 курсов ПХТ 5-ФУ в комбинации с цисплатином. При использовании этой комбинации удалось достичь 3-месячной выживаемости у 98,2%, 6- месячной выживаемости – у 80,7%, 9-месячной выживаемости – у 56,1%, одногодичной выживаемости – у 35,1% пациентов. Медиана наблюдаемой выживаемости составила $10,7 \pm 1,5$ месяцев.

В подгруппе В проведение 16 пациентам 46 курсов ПХТ капецитабином в комбинации с цисплатином позволило достичь 3-месячной выживаемости у 93,7%, 6- месячной выживаемости – у 81,2%, 9-месячной выживаемости – у 66,5%, одногодичной выживаемости – у 60,9% пациентов. Медиана выживаемости достигла $14,4 \pm 1,6$ месяцев.

Результаты исследования показали, что комбинация капецитабин+ цисплатин достоверно (Cox's F-Test: $F=3,7$; $P=0,00014$) увеличивает одногодичную выживаемость с 35,1% до 60,9% и медиану выживаемости с 10,7 до 14,4 месяцев по сравнению с комбинацией 5-ФУ+цисплатин (рисунок)

Закключение: таким образом, проведенное клиническое исследование комбинированных режимов ПХТ фторпиримидинами с цисплатином в качестве I линии химиотерапии распространенного рака печени показало удовлетворительные непосредственные и отдаленные результаты лечения. Кроме того, изученные комбинации продемонстрировали уровень токсичности приемлемый для клиники.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ

Жумакаев М.Д., Мусулманбеков К.Ж.

Карагандинский государственный медицинский университет.

КГКП «Областной онкологический диспансер», г. Караганда

Несмотря на постоянное совершенствование техники хирургического лечения рака головки поджелудочной железы послеоперационные осложнения и связанная с этим летальность остается высокой и составляет в среднем 50 % и 26,6 % соответственно.

Наиболее сложным и ответственным элементом реконструктивного этапа панкреатодуоденальной резекции является формирование панкреатодуоденального анастомоза. Это поистине «ахиллесова пята» всей операции, т.к. послеоперационная несостоятельность этого анастомоза влечет за собой цепь тяжелых осложнений и практически остается причиной летальных исходов.

Второе место, среди грозных послеоперационных осложнений занимает панкреатит. По данным отдельных авторов

наиболее частым послеоперационным осложнением является панкреатит, встречающийся в 20 – 50 %. По их мнению, они часто являются фактором риска развития недостаточности панкреатоюанального анастомоза и одной из ведущих причин послеоперационной летальности.

С целью профилактики острого панкреатита предлагается целый комплекс медикаментозных лечений и дренирование протока поджелудочной железы с наружным выведением дренажа, который нередко приводит к формированию стойких панкреатических свищей и развития малоабсорбции.

В основу работы положен анализ лечения 46 больных с опухолями панкреатодуоденальной зоны, которым проведено оперативное лечение в Карагандинском областном онкологическом диспансере за период с 1999 по 2009 годы с

внедрением нового, разработанного в клинике, хирургического подхода.

Возрастной состав больных распределился таким образом: чаще встречались больные в возрасте 50 - 59 лет и 60 - 69 лет, составляя 45,6 % и 32,6 % соответственно. Возраст самого молодого и пожилого больного составили 18 и 85 лет.

Соотношение мужчин и женщин составили 58,8 % (27), женщины 41,2 % (19).

Установлены следующие локализации опухоли: рак головки поджелудочной железы 62,8 % (28), рак большого дуоденального соска (БДС) 29,4 % (14). Тремя больным по поводу осложненных форм рака дистального отдела желудка и одному больному по поводу рака печеночного угла ободочной кишки с прорастанием головки поджелудочной железы (8,6%) произ-

ведена комбинированная панкреатодуоденальная резекция.

По результатам операционного материала установлены следующие гистологические формы опухоли: аденокарцинома высокой, средней и низкой степени дифференцировки, светлоклеточный вариант аденокарциномы, злокачественный карциноид с амилоидозом, железистотубулярная аденокарцинома, ацинарноклеточный рак, протоковая аденокарцинома.

Среди послеоперационных осложнений поддиафрагмальный абсцесс, внутреннее кровотечение в 2 случаях.

После операции умерло 2 больных (4,3 %) от сердечно-сосудистой недостаточности. Как видно из приведенных цифр послеоперационное осложнение и летальность составила 21,7 % и 4,3 % соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ

Сейсембаев М.А., Наржанов Б.А., Токсанбаев Д.С.,

Садыков Н.К., Молдабеков Е.Т., Исбамбетов А.С.

Национальный научный центр хирургии им. А. Н. Сызганова

Республика Казахстан, город Алматы

Цель. Улучшить результаты хирургического лечения больных с опухолями желчных протоков.

Материал и методы. В ННЦХ им. А. Н. Сызганова проанализированы результаты 72 больных со злокачественными опухолями желчных путей в возрасте от 37 до 80 лет, находившихся на лечении в отделении хирургии печени с 2003 – 2010 годы. Из них мужчин 42 (58,3%), женщин 30 (41,7%).

Для диагностики опухолей желчных протоков и причины механической желтухи использовались лабораторные, а также инструментальные методы исследования, как: УЗИ и доплерографией, МРХПГ, КТ, ЭРХПГ и ЧЧХС с фистулохолангиографией.

Основным проявлением заболевания явилась желтуха 100%, кожный зуд – 75,0%, холангит – 49,0%. Большинство пациентов 56 (77,8%) имели желтуху тяжелой степени тяжести (общий билирубин свыше 200 мкмоль/л). Операции проводились в два этапа; первым этапом с целью уменьшения печеночной недостаточности выполняли декомпрессию желчных путей (ЧЧХС, ЭРХПГ + стентирование), вторым этапом проводили основное оперативное вмешательство.

Результаты. Всего при опухолях желчных протоков выполнено 22 (29,1%) радикальных операций. Из них, в 15 случаях выполнены резекции опухолей желчных протоков с дополнительным иссечением передней части IVb сегмента печени, что обеспечило адекватный доступ к внутрипеченочным желчным протокам для формирования билиодигестивного анастомоза (би-, три-, тетрагепатикоюностомия) на изолированной Ру петле. В одном (1,4%) случае выполнена расширенная правосторонняя гемигепатэктомия, в 5 (6,9%) случаях – гастропанкреатодуоденальная резекция при опухолях терминального

отдела холедоха. При опухоли Клатскина с распространением в головку поджелудочной железы одному пациенту (1,4%) выполнена правосторонняя гемигепатэктомия + IVb сегмент и гастропанкреатодуоденальная резекция. В трех (4,2%) случаях из-за инвазии опухоли в стенку воротной вены произведено резекция с пластикой.

Паллиативное хирургическое лечение при опухолях желчных протоков выполнено 50 (69,5%) больным. Проведены следующие оперативные вмешательства: реканализация с дренированием желчных протоков – 24 (33,3%) пациентам, с наложением билиодигестивного анастомоза – 7 (9,7%) пациентам. Чрескожное чреспеченочное дренирование желчных протоков под УЗИ-контролем как окончательный вид хирургического вмешательства выполнено – 19 (26,4%) пациентам.

В послеоперационном периоде наблюдались специфические осложнения у 15 (20,8%) пациентов – желчеистечение с перитонитом, кровотечение и печеночно-почечная недостаточность. Летальность отмечено в 13 (18,0%) случаях, причиной которых были холангит, печеночная недостаточность и ТЭЛА.

Выводы. При опухолях желчных протоков с тяжелой степенью механической желтухой и печеночной недостаточностью необходимо проводить двухэтапное лечение, которое позволяет уменьшить частоту послеоперационных специфических осложнений и летальных исходов. Наличие опыта резекционных вмешательств на печени и желчных протоках, а также техническое оснащение операционного блока специфическим оборудованием, позволяет выполнить радикальное оперативное вмешательство и улучшить отдаленные результаты лечения.

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ОНКОКОЛОПРОКТОЛОГИИ

Хожяев А.А., Кайдаров Б.К., Балтаев Н.А., Шатковская О.В.,

Мещанинова И.В., Адиев М.М., Баймухаметов К.К.

Городской онкологический диспансер г.Алматы,

Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д.Асфендиярова

Актуальность. Высокий процент осложненных форм колоректального рака (КРР) сопровождается тем, что значительной части больных выполняются обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой колостомы на передней брюшной стенке. При этом реабилитационные мероприятия выходят на первый план, так как восстановление привычного «образа тела» остается доминирующей жизненной задачей этих больных, многие из которых в момент постановки диагноза

находятся в трудоспособном возрасте и профессионально востребованы. Как показывает практика, устранение инвадизирующего фактора остается главной задачей стомика на протяжении всего периода динамического наблюдения, оставляя на втором плане даже продолжительность жизни при наличии такого выраженного физического дефекта, как противоестественный задний проход.

Цель работы: улучшение качества жизни (КЖ) стомиро-

ванных больных КРР.

Материал и методы. В настоящее исследование включено 86 больных III клинической группы, находящихся на диспансерном учете в Городском онкологическом диспансере г. Алматы с диагнозом КРР и которым ранее в плановом или экстренном порядке были выполнены обструктивные резекции толстой кишки с формированием концевой абдоминальной колостомы с культей отключенной кишки: а) в левом боковом канале – 17, б) в малом тазу – 40, в) под тазовой брюшиной («короткая культя» прямой кишки) – 29 больных. При этом, 57 больных КРР, которым сформирован *anus praeternaturalis*, до первичной стомирующей операции занимались трудовой деятельностью, что составило $66,3 \pm 5,1\%$. Хирургический этап медицинской реабилитации заключался в устранении кишечной стомы и восстановлении естественного пассажа кишечного содержимого. Из них 19 больным выполнены реконструктивно-восстановительные операции с использованием механических аппаратных швов, а 67 больным – ручных двух- и однорядных швов. Несостоятельность межкишечного анастомоза составила 1,2%. КЖ оперированных пациентов изучалось с помощью опросника Европейской организации исследования и лечения рака – EORTC QLQ-C30 (version 3), состоящего из 5 функцио-

нальных шкал, 3 шкал симптоматики, шкалы общего качества жизни и 6 одиночных пунктов.

Результаты. Сравнительный анализ показателей КЖ больных КРР до восстановительной операции и во всех точках обследования после ликвидации колостомы показал, что статистически значимые различия ($p < 0,05$) по среднему баллу шкал опросника EORTC QLQ-C30 были выявлены по шкале общего КЖ (QL), функциональным шкалам: физическое функционирование (PF), ролевое функционирование (RF), эмоциональное функционирование (EF), социальное функционирование (SF) и шкале, отражающей финансовые затруднения (FI). Коэффициент «трудовой реабилитации» составил $84,2 \pm 4,8\%$. При этом из 48 больных, которые вернулись к труду после реконструкции кишечника, только $14,6 \pm 5,1\%$ (7 человек) пришлось пройти переквалификацию и поменять вид трудовой деятельности.

Заключение. Выполнение реконструктивно-восстановительных операций, как хирургического этапа медицинской реабилитации у стомированных больных КРР, позволяет значительно улучшить их КЖ и подавляющему числу пациентов вернуться к трудовой деятельности, в том числе в основном – без переквалификации.

РОЛЬ ИМПЛАНТОВ И ЭСПАНДЕРОВ В РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Исмаилов А.Х., Гимранов А.М., Губайдуллин Х.М., Ванесян А.С.

Казанская государственная медицинская академия

Увеличение продолжительности жизни и показателей общей и безрецидивной выживаемости, ставит вопрос о качестве жизни пациентов, резко падающего в результате проведенного радикального лечения. Органосохранная и реконструктивно-пластическая хирургия должна являться интегрированной частью хирургического лечения рака молочной железы. Поскольку органосохранные операции показаны только определенной группе пациентов, то перед хирургом стоит вопрос о способе возмещения удаленной молочной железы. В арсенале присутствует либо использование аутологических тканей, либо реконструкция алломатериалами (экспандеры и/или импланты). У каждого метода есть свои преимущества и недостатки. Преимуществами аутологических тканей являются их пластичность, индивидуализация моделирования и более высокий процент достижения симметрии. Существенными недостатками реконструкции лоскутами являются травматичность операции, непредсказуемость результатов (ишемические осложнения) и относительная необратимость операций. При реконструкции молочной железы экспандерами и имплантами можно назвать следующие преимущества: простота выполнения, меньшая травматичность и минимальное количество послеоперационных рубцов (отсутствие донорской зоны). Недостатками являются дороговизна изделия, сложность достижения начальной и (или) стабильной симметрии, повышение риска фиброзной контрактуры после проведения лучевой терапии, вероятность потери протеза в условиях длительной лимфореи, вследствие нагноения, или повреждения протеза.

При реконструкции молочных желез алломатериалами применяется одноэтапная или двухэтапная методика. При одноэтапной методике можно использовать перманентный

экспандер - имплант или имплант. При двухэтапной методике подразумевается постановка экспандера на первом этапе, а после растяжения кожи до необходимых объемов – постановка импланта. Выбор методики заложен на наш взгляд в названии, одноэтапность подразумевает собой, что хирург уверен в обеспечении окончательного результата за один раз, в противном случае нужно прибегать к двух-этапной операции.

Одноэтапная реконструкция имплантом показана в следующих случаях: небольшая грудь без птоза, кожносохранная мастэктомия (без дефицита кожи, нет необходимости дермотензии). Показания к пластике перманентными экспандерами – имплантами включают показания пластики имплантами, а также: небольшой дефицит кармана (при условии сохранения инфрамаммарной складки) и неуверенность с точным определением объема импланта.

Показания к двухэтапной методике: отсроченные реконструкции (при которых субмаммарная складка отсутствует), одномоментные реконструкции при опухолях T3, T4 (субмаммарная складка разрушается в процессе мастэктомии), планирование ДЛТ (есть возможность иссечения фиброзно-измененной капсулы в процессе замены экспандера на имплант, проблемная (сложная) грудь, небольшой опыт (если, что-то не решилось на первом этапе, есть возможность исправления на втором).

Таким образом данный алгоритм, позволяет избежать хаоса в показаниях к применению алломатериалов в реконструктивно-пластической хирургии молочной железы, позволяя избежать много-этапности, в тех случаях когда результат достигается за один раз, и наоборот не формировать инфрамаммарную складку на имплантах, дискредитируя одноэтапность.